Borstverkleining (mammareductie)

Deze folder bevat informatie voor vrouwen die een borstverkleinende operatie overwegen en/of laten uitvoeren.

Waarom een borstverkleinende operatie?

Grote, zware borsten zijn voor veel vrouwen een probleem. Zowel lichamelijk als psychisch. Vrouwen die een borstverkleinende operatie laten uitvoeren, doen dit meestal juist niet om cosmetische redenen.

Lichamelijke problemen kunnen zijn:

- Pijn in schouders, rug en hals
- Pijnlijke en gevoelige borsten
- BH-bandjes knellen
- Belemmering bij sporten en intensief bewegen
- Huidirritatie onder de borsten
- Geen passende kleding kunnen vinden

Psychische problemen kunnen zijn:

- Het als vervelend ervaren als de omgeving opmerkingen maakt over grote borsten
- Het eigen idee over grote borsten

Belangrijk

Borstverkleiningen worden in de regel **niet** uitgevoerd als iemand te zwaar is (BMI hoger dan 30).Overgewicht kan leiden tot complicaties tijdens én na de operatie. Ook wordt de operatie bij een BMI hoge dan 30 niet vergoed door de zorgverzekering. Het is raadzaam om, in overleg met de huisarts, een dieet te volgen om af te vallen. Zodra het gewenste gewicht is bereikt, kan een nieuwe afspraak met de plastisch chirurg worden gemaakt. De operatie kan dan zonder onnodige risico's worden uitgevoerd.

Voorbereidingen thuis

Voorbereidingen thuis

- **Medicatie:** Gebruik je bloedverdunners? Meld dit aan je arts, deze kunnen tijdelijk worden gestopt. Stop medicatie alleen in overleg met je arts/ anesthesioloog.
- **Voeding:** Voor een goed wondherstel na de operatie helpt het als je vooraf een goede voedingstoestand en conditie heeft. Om dit te ondersteunen kan je extra eiwitten eten en eventueel vitamine C1000 slikken. Hiermee kun je 2 weken voor de operatie starten en tot 1 week na de operatie doorgaan.
- **Roken:** Stop minstens 6 weken voor én na de operatie met roken om wondgenezingsproblemen te voorkomen.

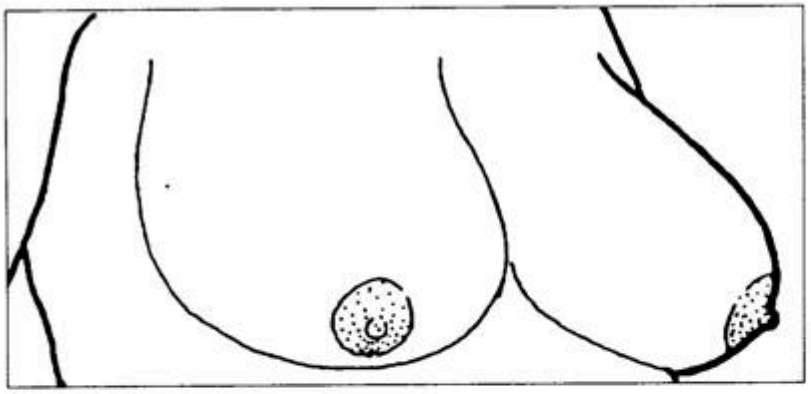
- **Praktisch:** Neem een pyjama mee met knoopsluiting voor het gemak bij wondverzorging. Regel hulp in huis voor de eerste weken na de operatie.
- **Nuchter zijn:** Volg de instructies over niet eten en drinken voorafgaand aan de operatie

Vóór de operatie

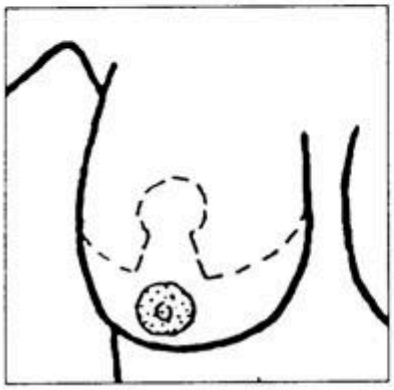
De plastisch chirurg tekent voorafgaand aan de operatie af waar het litteken komt. Meestal loopt het litteken rond de tepel naar beneden en in de borstplooi. Vóór en 3 maanden na de operatie worden medische foto's gemaakt voor in jouw dossier.

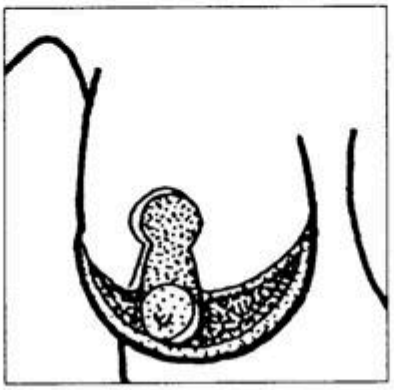
De operatie

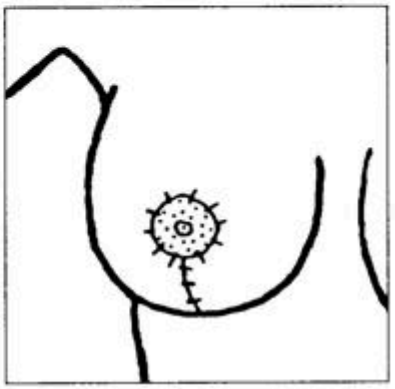
De borstverkleinende operatie vindt vaak plaats in dagbehandeling. Dat betekent dat je in de meeste gevallen na de operatie op dezelfde dag naar huis kunt. De operatie duurt ongeveer 1,5 uur en wordt uitgevoerd onder algehele narcose. Meestal wordt de borst verkleind door het weghalen van huid en klierweefsel aan de onderkant. Om een natuurlijke borstvorm te bereiken, wordt een 'figuurnaad' aangelegd. Die loopt van de tepel recht naar beneden en in de borstplooi. Vervolgens wordt de tepel verplaatst. Soms wordt een verkleining van de tepelhof uitgevoerd. Aan het einde van de operatie is het soms nodig om een wonddrain te plaatsen. Een wonddrain is een slangetje dat vocht en bloed in het wondgebied afvoert. Zo ontstaat er geen opeenhoping en wordt druk op de wond voorkomen.



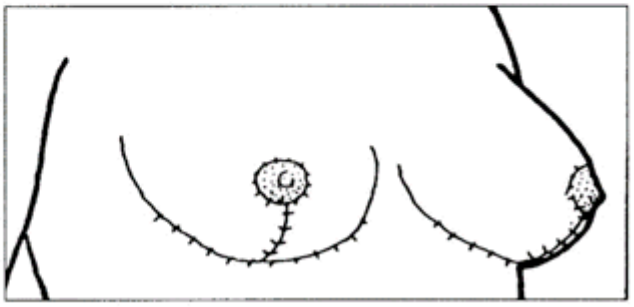
Borstverkleining door middel van de 'sleutelgat-techniek', waarbij de tepel intact blijft en naar boven wordt verplaatst. Er onstaat een anker-vormig litteken.

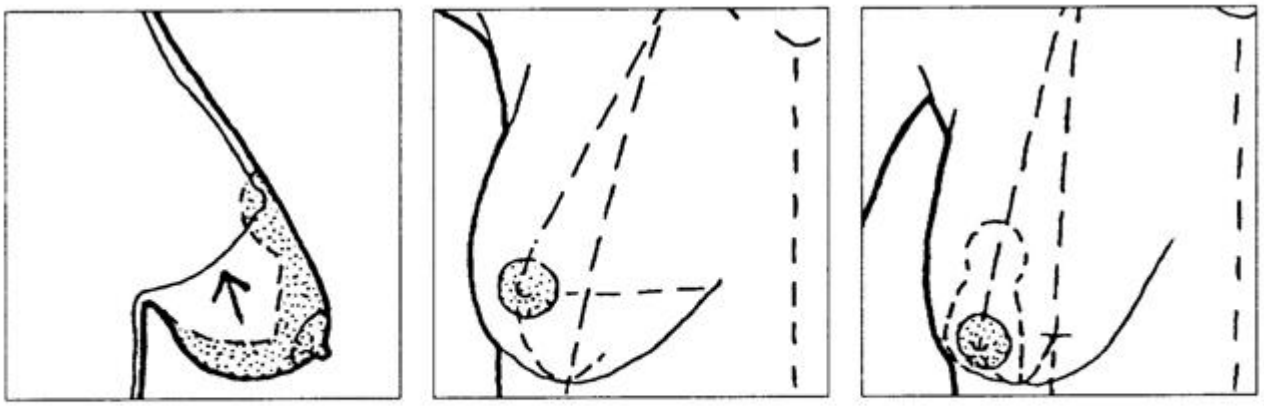






Bij extreem grote borsten moet een groot deel van de borst worden verwijderd. De tepel wordt losgesneden en getransplanteerd.





De plaats van de tepel (op gelijke hoogte met de borstplooi) wordt gemarkeerd in staande houding.

Na de operatie

Na een borstverkleinende operatie voelen de borsten soms pijnlijk en gespannen aan en kunnen er zichtbare blauwe plekken zijn. Dit wordt binnen een paar dagen minder. Je mag de voorgeschreven medicijnen tegen de pijn gebruiken.

De littekens kunnen in de eerste maanden verdikt, rood en gevoelig zijn en strak aanvoelen. Na een aantal maanden zullen de zwelling en gevoeligheid afnemen en wordt het litteken in de meeste gevallen minder opvallend.

Bij ontslag uit het ziekenhuis wordt alvast een controle-afspraak ingepland voor op de polikliniek Plastische chirurgie. Tijdens dit bezoek wordt de wond gecontroleerd en worden zo nodig de hechtknoopjes die uitsteken verwijderd.

Na ongeveer 6 maanden zullen je borsten hun definitieve vorm hebben.

Adviezen na de operatie:

- Je hebt een stevige BH aangekregen. Deze BH draag je gedurende 6 weken dag en nacht. Bij het douchen mag deze even uit en daarna een uurtje luchten. Het dragen van deze BH zorgt dat de borst goed wordt ondersteund waar door je vaak minder last heeft van de littekens en blauwe plekken.
- De hechtpleisters laat je zitten tot aan de controle-afspraak op de polikliniek. Eventuele gazen mag je (indien nodig) vervangen voor schone.
- De eerste 24 uur dien je de wonden droog te houden. Daarna mag je douchen (zeep is toegestaan, goed naspoelen). De pleistertjes mogen nat worden.
- Je mag gedurende 6 weken niet baden, zwemmen, naar de zonnebank of een sauna bezoeken.
- Beweeg de schouders en armen normaal, maar hef de eerste 2 weken de armen niet boven 90 graden in het schoudergewricht.
- Gedurende 2 weken mag je niet zwaarder tillen dan 5 kg.
- Gedurende 6 weken mag je niet sporten en geen zwaar huishoudelijk werk verrichten (stofzuigen, ramen zemen, strijken of een boodschappentas tillen). Lichte activiteit zoals wandelen is toegestaan.
- Na 4 weken kun je het litteken (indien goed hersteld) insmeren en masseren met een hydraterende crème of een olie.
- Autorijden en fietsen kan doorgaans weer na een week of 2 tot 4 als je voelt dat je verantwoord kunt rijden.
- Slaap gedurende 6 weken niet op de buik en 1 week niet op de zij.
- Het is belangrijk om je litteken zo lang het rood is, niet bloot te stellen aan ultraviolet licht (zon of zonnebank). Je kunt het litteken beschermen met een pleister of in een later stadium met een hoge zonnebrandfactor.
- Heb je de drain meegekregen naar huis? Kijk dan ook in de folder *'Naar huis met een wonddrain (redondrain)'.*

Het te verwachten resultaat

Na de operatie zijn de borsten kleiner en steviger, maar er zijn wel blijvende littekens. Hoe deze littekens eruitzien, verschilt per patiënt. Er kan helaas géén garantie gegeven worden voor een goed resultaat of voor symmetrie van de borsten. Het uiteindelijke resultaat kan soms tegenvallen door enige ongelijkheid van de borsten, of doordat de tepels wat minder of toegenomen gevoelig zijn geworden.

Denk ook aan de volgende punten:

- In een enkel geval is na minimaal een jaar een kleine correctie nodig om een optimaal resultaat te bereiken.
- Door pilgebruik, zwangerschap of gewichtstoename kunnen de borsten weer groter worden.
- Door vermagering kunnen borsten mogelijk wat verslappen.
- Een borstverkleinende operatie kan ervoor zorgen dat borstvoeding geven niet meer mogelijk is.

Mogelijke complicaties

Na elke operatie, hoe zorgvuldig uitgevoerd ook, kunnen complicaties optreden. Voor deze operatie zijn dat:

- Een **allergische reactie** op gebruikte verdovingsvloeistoffen of materialen.
- Een **verminderd gevoel** van de borst/tepel. Soms herstelt het gevoel zich geheel of gedeeltelijk.
- **Infecties** van de wond(en).
- **Wondproblemen**, zoals het opengaan van de wond(en) of vertraagde wondgenezing. Weefselversterf (van de tepel) komt zelden voor. Deze verschijnselen kunnen echter wel leiden tot een tegenvallend cosmetisch resultaat.
- **Bloeduitstortingen** komen regelmatig voor na deze ingreep en zullen binnen een aantal weken afnemen.
- Bij een **nabloeding** merk je dat de borst in korte tijd erg zwelt (en soms blauw wordt). In geval van een nabloeding moeten wij jeopnieuw opereren om de bloeding te stelpen.
- **Littekens** die dik, strak of pijnlijk kunnen worden.
- **Diep veneuze trombose of longembolie**: Tijdens de operatie kan er een bloedpropje ontstaan in een van de aderen, die later kan losschieten.

Deze risico's en complicaties, evenals het belang van het stoppen met roken zijn tijdens het consult met de arts met je besproken. Hoewel de operatie met de grootste zorg zal worden uitgevoerd, is het voor ons niet mogelijk om garanties te geven, omdat het genezingsproces verschilt per individu.

Kosten operatie

Een borstverkleinende operatie wordt alleen vergoed als er minimaal sprake is van een D-cup óf als de borsten uitgesproken ongelijk van grootte zijn. De beslissing hierover wordt genomen door de medisch adviseur van de zorgverzekeraar.

Krijg je de operatie niet vergoed? Je kunt de operatie eventueel voor eigen rekening laten uitvoeren. Je kunt dan via het secretariaat van de polikliniek Plastische chirurgie een offerte opvragen.

Vragen en contact

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen, dan kun je contact opnemen met de polikliniek Plastische chirurgie.

- op werkdagen van 8.00 – 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur,
- telefoon Den Haag: (070) 210 7760
- telefoon Zoetermeer: (079) 346 2804

Wanneer neem je na de operatie contact op?

- Koorts (38.5° C of hoger) en/of niet lekker voelen
- Plotselinge enorme zwelling van de borst of wondgebied.

- Roodheid van de huid rondom de wond
- Veel nabloeden van de wond, opengaan van de wond of veel vochtlekkage

Als één van bovenstaande symptomen zich voordoet, kun je contact opnemen met de polikliniek van je eigen ziekenhuislocatie: locatie Den Haag of locatie Zoetermeer.

Krijg je bovenstaande klachten in het weekend, 's avonds of 's nachts, neem dan contact op met:

- de Spoedeisende Hulp (SEH) Den Haag tel: 070 – 210 20 60
- de Spoedeisende Hulp (SEH) Zoetermeer tel: 079 – 346 25 39

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

140223122025